9.4 직원안전 관리활동			
규 정 번 호	9.4	제 정 일	3주기 규정집 제정
관련 인증기준	9.4 직원안전 관리활동	최근 개정일	2025-10-15
담 당 부 서	원무과, 보건관리자, 감염관리전담자	시 행 일	2025-11-01
검 토 책 임 자	병원 운영위원회	검 토 주 기	2년
승 인 책 임 자	병원장	검토 예정일	2027-10-15
관 련 근 거	1. 산업안전보건법 2. 근로기준법 3. 남녀고용평등법 4. 결핵예방법 시행규칙 5. 양성평등기본법		

▣ 목적

의료기관은 직원의 건강유지와 업무와 관련된 직원의 안전사고를 최소화하기 위하여 안전관리활동을 계획한다. 이를 위하여 의료기관은 직원 건강관리에 대한 요구도 파악, 감염 노출을 포함한 직원 안전사고 조사, 상담 및 추후관리를 통한 직원 건강유지 및 감염성질환 전파 감소를 위한 활동을 수행한다.

▣ 용어의 정의

직원 건강검진: 질병의 조기발견 및 예방조치를 통한 직원의 건강 증진을 위해 실시하는 의학적 진료를 말한다.

직원 안전사고: 업무 중 작업과정, 작업 기계, 작업환경과 관련된 상해를 말한다.

주사침 자상: 오염된 주사침이나 날카로운 물체(뾰족한 기구 등)에 찔리거나 베이는 사고로 인하여 혈액 및 체액을 매개로 하여 본인에게 질환을 유발하고 이로 인하여 타인에게 질환을 유발 할 수 있는 위험성을 가진 사고를 말한다.

보건관리자: 병원 내 유해인자, 작업방법 및 업무부담 등으로 인하여 발생할 수 있는 각종 질병으로부터 직원의 건강관리 업무를 담당하는 직원으로서 고용노동부에 선임된 자를 말한다.

▣ 정책

^N 직원 건강유지 및 안전 관리활동에 대한 규정이 있다.
^N 직원 건강유지 및 안전 관리활동 계획이 있다.
^N 직원 건강유지 및 안전 관리활동을 수행한다.
^N 직원 안전사고 관리에 대한 규정이 있다.
^N 직원 안전사고 발생 시 보고하고 치료 및 관리한다.
^N 직원 안전사고 처리결과를 경영진에게 보고한다.

▣ 지침 및 절차

1. 직원건강유지 및 안전관리 활동 계획 수립

가. 보건관리자는 매년 1회 12월마다 시행시기와 예산이 포함된 직원 건강유지 및 안전관리 활동 계획을 수립한다.

나. 직원 건강유지 및 안전 관리활동 계획 수립의 내용은 다음과 같다.

1) 직원 건강검진

2) 직원에 대한 감염예방을 위한 점검 활동
3) 직원의 예방접종
4) 직원의 안전 및 보건 유지 증진
5) 유해물질 및 유해환경 관리
6) 직원의 건강증진 프로그램 운영

2. 직원건강검진

가. 신규 직원 및 재직직원의 건강검진은 원무과가 검진일정, 검진기관 등을 결정 및 주관하고 직원 공지가 필요한 경우 원내 공지를 통하여 수검이 이뤄지도록 관리한다.

나. 신규직원 일반건강검진 및 관리

1) 신규직원은 본원에 입사 시 아래의 건강검진 결과표를 총무팀에 제출하여야 한다.

대상자	건강검진 항목	실시시기	비고
신규직원	채용검진	채용 시	
	B형간염검사		
	잠복결핵검사	입사일로부터 1개월 이내	이전 검사결과 갈음 가능

2) 단, 입사일로부터 6개월 이전 실시한 건강검진 결과지가 있을 경우 해당 검사 결과지로 갈음하여 제출할 수 있다.
3) 보건관리자는 산업안전보건법 시행령 제 22조(보건관리자의 업무)에 따라 신규직원이 제출한 건강진단 결과 발견된 요양 지도 및 관리가 필요한 사항에 대해 상담 및 관리하고 보건 상담일지에 기록한다.

다. 재직직원 일반건강검진 및 관리

1) 재직직원은 산업안전보건법 시행규칙 제 197조(일반건강진단의 주기 등)에 따라 사무직은 2년에 1회 이상, 비 사무직은 1년에 1회 이상 일반건강진단을 실시해야 한다.
2) 단, 산업안전보건법 제 129조(일반건강진단) 및 동법 시행규칙 제 196조(일반건강진단 실시의 인정)에 따라 국민건강보험법에 따른 건강검진을 실시 하였거나 아래의 검사항목을 모두 포함하여 실시한 건강진단 결과표가 있을 경우 일반건강진단을 실시한 것으로 본다.
   가) 과거병력, 작업경력 및 자각·타각증상(시진·촉진·청진 및 문진)
   나) 혈압·혈당·요당·요단백 및 빈혈검사
   다) 체중·시력 및 청력
   라) 흉부방사선 촬영
   마) AST(SGOT) 및 ALT(SGPT),γ-GTP 및 총콜레스테롤
3) 재직직원 또한 보건관리자는 재직직원이 제출한 건강진단 결과 발견된 요양 지도 및 관리가 필요한 사항에 대해 상담 및 관리하고 보건 상담일지에 기록한다.

라. 특수부서 건강검진 및 관리

1) 영양실 : 식품위생법 제 40조(건강진단) 및 동법 제 49조(건강진단 대상자)에 따라 영양실에 근무하려는 자는 식품위생 분야 종사자의 건강진단 규칙 제 2조에 따라 건강진단을 받아야 하며 영양실 근로자는 영양사에게 보건증을 제출하여야 한다.
   가) 건강진단의 유효기간은 1년으로 하며, 유효기간 만료일 전후 각각 30일 이내 실시하여 영양사

에게 제출하여야 한다.

2) 방사선실 : 진단용 방사선 발생장치의 안전관리에 관한 규칙 제 13조(방사선 관계 종사자에 대한 건강진단)에 따라 방사선 관계 종사자는 2년마다 방사선 관계 종사자 건강진단표를 제출하거나 산업안전보건법 제 130조에 따라 입사 시 배치전건강진단과 특수건강진단을 실시한 경우 방사선 관계 종사자 건강진단을 실시한 것으로 본다.

마. 부서배치 시 고려해야 할 사전 건강검진 및 정기검진

1) 「산업안전보건법 시행규칙」에 따라 유해인자에 노출되는 업무에 종사하는 근로자 대상으로 1회/년 이상 실시한다.

2) 작업환경측정결과에 따른 유해인자를 확인한다.

3) 대상자: 「산업안전보건법 시행규칙」 별표22

가) 야간작업

(1) 6개월간 밤 12시부터 오전 5시까지의 시간을 포함하여 계속되는 8시간 작업을 월 평균 4회 이상 수행하는 경우

(2) 6개월간 오후 10시부터 다음날 오전 6시 사이의 시간 중 작업을 월 평균 60시간 이상 수행

건강검진 명	실시시기	실시 대상자	유해인자
배치전 건강검진	배치 전 (입사일로부터 1개월 이내 가능)	야간 전담 근로자 야간 근로를 포함한 근로자 방사선사	야간근로 전리방사선
배치 후 6개월 이내 검사	배치 후 6개월 이내		
특수건강검진	12개월		

3. 직원 감염 예방을 위한 점검활동

가. 대상은 의료기관 내에 근무하는 모든 직원이다.

1) 모든 의료인은 필수로 적용하고 정규직, 계약직을 구분하지 않는다.

나. 직원 채용 시 근무 시작 전 직원의 현성감염 여부 및 노출경험 또는 보균상태를 확인한다.

1) 신규직원은 입사 시 흉부 X-선 검사(결핵검사), 잠복결핵 검사를 통해 결핵 감염여부를 확인한다.

대상자	실시시기	건강검진 항목	검사방법
신규 직원	직원 채용 시	결핵	Chest X-ray
		잠복결핵	IGRA 검사

다. 감염노출 위험부서로 직원 배치 전(근무 시작 전) 추가 점검 시행 및 필요시 예방접종을 시행 한다.

감염노출 위험 부서	간호부, 재활치료실
추가 점검	직원 배치 전 B형간염 검사를 통해 항체형성 여부 확인
예방접종 대상	혈액노출 위험 직종(의사, 간호사, 간호조무사, 치료사)
관리 사항	감염관리전담자는 HBsAb 음성일 경우 해당 직원에게 예방접종을 권고한다.

라. 유소견자 발견 시 절차

1) 감염관리전담자는 유소견자 발견 시 상담을 통해 필요 시 추가 검사 및 예방접종을 시행하도록 한다.
2) 진료결과에 따라 해당부서에서 근무가 불가능한 경우 부서장에게 보고하고 병원운영위원회에 안건을 상정하여 근무지 배치전환에 관해 검토한다.
   가) 결핵
      (1) 보건복지부 [의료기관 결핵관리 안내] 지침을 따른다.
      (2) 흉부 X-선 검사 결과 유소견자는 진료의사의 진단에 따라 추가검사(객담검사 등)를 시행하여 활동성 결핵여부를 확인한다.
      (3) 검사 결과에 따라 활동성 결핵인 경우 근무를 제한하고 치료를 실시하고, 비 활동성 결핵인 경우 활동성 결핵의 가능성 배제를 위한 추가 검진(객담검사 등)을 시행하고, 치료력이 없는 비 활동성 결핵의 경우 잠복결핵감염 치료를 권고한다.
   나) 잠복결핵
      (1) 보건복지부 [의료기관 결핵관리 안내] 지침을 따른다.
      (2) 잠복결핵 검사 결과 양성자는 치료를 권고한다.
      (3) 잠복결핵 검사결과 양성인 경우 증상 발현 유무를 주의깊게 관찰한다.
      (4) 연 1회 이상 흉부 X-선 검사를 통해 결핵 감염여부를 확인한다.
   다) B형간염
      (1) B형간염의 항체가 없는 직원은 B형간염 예방접종을 하도록 권고한다.

마. 건강검진 미시행자에 대한 조치

1) 「산업안전보건법 제129조(일반건강진단), 제130조(특수건강진단 등)」에 의거, 건강검진 대상자는 당해 연도에 필히 수검이 이루어지도록 한다.
2) 총무팀에서는 미수검자에 대하여 개인 및 소속 부서장에게 통보하여 미수검자가 발생 하지 않도록 하고 건강검진 미 수검자 관리 대장에 기록한다.

4. 직원 예방접종

가. 직원 예방접종의 종류와 적용대상은 다음과 같다.

가) 종류: 인플루엔자
나) 대상: 전 직원(단, 부작용 예상 직원 제외)
다) 시기: 매년 인플루엔자가 유행하기 전인 9~12월 중 단, 매년 유행형이 바뀌므로 새로운 유형의 예방접종을 실시할 수 있다.

1) 예방접종 관리 절차

가) 병원운영위원회를 통하여 주사제 종류, 접종 시기, 대상(인원 수) 등을 선정하고 접종일자, 접종 장소 등은 원내 공지로 직원과 공유하며 보건관리자가 접종을 주관한다.

나) 병원에 근무하는 전 직원을 대상으로 한다.

5. 직원의 안전 및 보건 유지·증진

가. 안전보건교육: 소속근로자에 대한 안전보건교육을 「산업안전보건법 제29조」에 따라 원내 교육체계에 따라 다음과 같이 안전보건교육을 실시한다.

1) 신규 채용 시 교육 : 신규 입사 직원은 부서 배치 전(또는 입사 시) 산업안전보건 채용 시 교육(8시간 이상, 온라인 위탁과정 「신규채용자 산업안전보건교육」 및 「배치전 교육」을 필수로 이수한다.

2) 재직직원 정기 교육 : 재직 근로자는 매 반기별(사무직 6시간 이상, 비사무직 12시간 이상) 정기 안전보건교육을 이수하며, 외부 위탁기관 또는 보건관리자가 주관하여 실시한다.

3) 교육 결과 관리 : 교육 이수 결과 및 수료 근거자료는 원무과로 통보하여 「9.1 인사정보 관리」 규정에 따라 직원의 인사기록카드에 기록·유지하며, 세부 교육 계획 및 미이수자 관리는 「9.2 직원교육」 규정을 준용한다.

나. 신체적 피로 및 정신적 스트레스 등으로 인한 건강장해예방 및 산업재해예방을 위해 근골격계 질환 유해요인조사를 3년 주기로 실시하며 2년 주기로 직무스트레스 요인 조사를 실시한다.

6. 유해물질 및 유해환경 관리

가. 작업환경관리 측정 및 관리

1) 대상부서: 「산업안전보건법 시행규칙 별표21」의 유해인자에 노출되는 근로자가 있는 작업장

2) 실시주기: 「산업안전보건법」에 의거 작업환경측정 대상 작업장이 된 경우 고용노동부장관이 지정하는 측정기관에 의뢰하여 반기별 1회 측정하며 사용하는 화학물질의 변경이 없고 작업환경측정 결과에 영향을 주는 변화가 없는 경우 연 1회 이상 실시할 수 있다.

3) 측정항목: 금속류, 유기화합물, 산, 알칼리류, 가스 상 물질류, 소음, 분진, 온열 등 「산업안전보건법 시행규칙 별표21」 유해인자

4) 작업환경 측정 결과 「산업안전보건법」의 기준을 초과하는 경우 이에 따른 작업환경을 개선한다.

5) 작업환경 측정 결과 및 개선 권고 사항은 해당 부서의 직원과 공유한다.

6) 다만, 산업안전보건법 시행규칙 제 186조에 의거 작업환경측정 대상 유해인자의 노출 수준이 노출기준에 비해 현저히 낮은 경우 작업환경 측정을 하지 않을수 있다.

7. 직원의 건강증진 프로그램 운영

가. 보건관리자는 직원의 건강을 증진시키기 위해 원하는 직원을 대상으로 건강증진 프로그램을 수립, 운영한다.

나. 금연, 절주, 영양, 운동 등에 대학 교육, 상담, 지원 등 실시 할 수 있다.

다. 월 1회, 분기별, 연 1회 등 프로그램의 시기는 계획에 따라 실시한다.

라. 직원 건강 증진 프로그램 운영결과를 병원운영위원회에 보고한다.

8. 감염노출을 포함한 직원 안전사고 관리

가. 직원 안전사고 유형

1) 감염노출사고: 직원이 피부나 점막 손상을 통해 혈액매개 감염질환에 노출된 사고 및 기타 경로로 혈액 외 감염질환에 노출된 사고
2) 감염 외 사고: 직원에게 발생한 모든 안전사고 중 감염노출사고를 제외한 경우
   가) 산업재해: 업무상의 사유에 따른 직원의 부상, 질병, 신체장애 또는 사망사고
   나) 중대재해: 사망자가 1인 이상 발생한 경우, 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 경우, 부상자 또는 직업성 질병자가 동시에 10명 이상 발생한 사고
3) 유해물질 노출 사고: 직원이 피부나 점막 혹은 호흡기 등을 통해 유해화학물질 및 일반관리물질 등에 노출된 사고

나. 직원 안전사고 예방 지침

1) 신규 및 재직직원을 대상으로 안전, 보건교육을 실시한다.
2) 감염노출사고(주사침 자상 예방 등) 예방 활동은 다음과 같다.
   가) 주사침 자상 예방 지침
      (1) 사용한 주사바늘, 날카로운 기구는 찔리지 않도록 조심한다.
      (2) 사용한 바늘은 다시 뚜껑을 씌우거나 구부리거나 자르지 말고 그대로 손상성 폐기물 전용 용기에 버린다.
      (3) Recapping 하는 경우 바늘에 뚜껑 씌우기를 하기 위해 한 손으로 Cap을 씌운다.
      (4) 손상성 폐기물 용기는 80% 미만으로 넣는다.
      (5) 사용기간이 완료된 손상성 폐기물 용기는 뚜껑을 완전히 밀폐하여 수거한다.
   나) 직원 감염 노출 예방을 위한 일반적 지침
      직원은 모든 환자를 대하는 과정에서 감염에 노출되지 않도록 주의한다.
      (1) 적용대상: 병원 내 근무하는 모든 직원
      (2) 감염 가능성 범위
      표준주의 지침에 따라 환자의 진단명, 처치의 종류, 감염 상태와 관계없이 모든 환자의 혈액과 체액, 분비물, 점막, 손상된 피부는 감염 가능성이 있는 것으로 간주하고 조심히 다룬다.
      (3) 손위생
      모든 의료진은 손위생의 중요성을 인식하고「1.3 손위생 수행 규정」을 준수하며, 검체채취 시 채취 전 손위생 시행 후 필요시 장갑을 착용하고, 채취 후 장갑을 벗고 나서 즉시 손위생을 수행한다.
      (4) 개인보호구 착용
      혈액, 체액, 분비물, 배설물 등이 튈 가능성이 있는 경우 개인보호구(가운, 고글, 마스크 등)를 착용한다.
      (5) 피부염, 상처 있는 직원: 피부염, 상처가 있는 직원은 환자와의 직접 접촉이나 검체 다루는 것을 피하도록 한다.
   다) 감염병 환자에 대한 표식방법 및 검체 취급 방법: [2.3.3 검체검사 안전관리] 규정 및 [7.7 감염성질환 환자 관리] 규정을 준수한다.

9. 직원 안전사고 발생 시 보고체계 및 치료•관리

가. 직원 감염 노출 시 안전사고 보고체계

1) 보고대상

가) 혈액매개감염원 노출 시: B형간염, C형간염, 매독, HIV, 주사침 자상

나) 공기매개감염원 노출 시: 홍역, 수두, 활동성 폐결핵 등

다) 비말감염원 노출 시: 유행선이하선염, 백일해, 인플루엔자, 대유행중인 호흡기 질환 등

라) 접촉감염원 노출 시: A형 간염, 노로바이러스, 옴 등

2) 보고받는 부서 및 담당자

가) 직원 감염노출 사고 발생 시에는 적절한 응급조치를 시행하고 해당 부서장에게보고한다.

나) 부서장은 감염관리전담자에게 즉시 구두 또는 유선(210) 보고 한다.

다) 평일 주간은 본원 외래, 야간에는 타병원 응급실 진료 후 부서장은 감염관리자 전담자에게 감염노출 사고 보고서를 72시간 이내에 제출한다.

라) 감염관리 전담자는 해당 직원에게 추후 관리 및 관리에 대해 안내하고 병원장에게 보고한다.

3) 보고 내용

가) 노출 직원의 직원명, 노출 날짜, 노출 장소, 노출 경로, 노출 대상, 임신여부, 감염예방을 위한 조치 사항 등이 포함되도록 하며 처리 절차는 다음과 같다.

나) 감염 노출자는 즉시 응급조치하고 환자의 감염 위험요인을 확인하며 부서장에게 보고한다.

다) 부서장은 직원안전사고 발생 보고체계에 따라 감염관리전담자에게 구두 보고하고 72시간 이내에 감염노출 보고서를 작성하여 제출한다.

라) 감염관리실에서는 작성된 감염노출보고서를 검토하고 감염관리실장과 상의하여 검사 및 처치 내용을 확정하고, 검사와 처치가 이루어지도록 조치한다.

마) 감염관리실은 감염노출 직원에 대한 교육 및 추후관리를 실시한다.

바) 감염관리실은 감염노출 경위 분석 등 사후 처리 후 병원장 및 감염관리 위원회에 서면으로 보고한다.

나. 전파 경로에 다른 치료 및 관리절차

1) 직원 감염 노출 시 전파 경로에 따른 치료 및 관리절차

가) 혈액매개 질환 노출 시 조치사항

(1) B형간염: 가능한 빨리 노출여부 확인을 위한 검사를 시행하고 약 6개월 후에 추적검사를 시행하며 별도의 근무제한은 필요하지 않는다.

(2) C형간염: 노출 후 면역글로불린 및 항바이러스제 투여는 필요하지 않으며 HCV 감염의심 시 적절한 치료가 필요함. 추적검사 실시. 임신, 수유에 관한특별조치 및 별도의 근무제한은 필요하지 않음

(3) HIV: 노출 후 72시간 내 항레트로바이러스제제 4주 투여함. 부작용의 위험과 예방효능을 모두 고려하여 모든 경우에서 3가지 약제 투여를 권고함.따라 추적검사 실시. 수유는 금지되며, 근무제한은 필요 없음

(4) 매독

(가) VDRL 양성이면서 피부감염이나 중추 신경계 감염 증상이 있는 환자에게 노출된 후 즉시 benzathine penicillin G 240만 단위 1회 근육주사 후 추적검사 실시함

(나) 증상이 없는 VDRL 양성환자에게 노출된 경우 6주 후 추적검사에서 VDRL 양성으로 확인되면 benzathine penicillin G 240만 단위 1회 근육주사 함

(5) 기타 혈액 및 체액 노출 시 조치사항

(가) 자상(주사바늘 찔림, 날카로운 기구에 베임) 부위에서 피가 흐르도록 하고, 흐르는 물과 비누로 씻은 후 베타딘 또는 알코올 등의 소독제로 소독한다.

(나) 점막(눈, 코, 입 등)에 혈액, 체액이 튄 경우에는 Eye wash station을 사용하여 충분히 씻어내고 이상 증상 시 즉시 진료를 받도록 한다.

나) 공기매개 질환 노출 시 조치사항

(1) 활동성 폐결핵 노출 직원 관리

(가) 병동에서 폐결핵 환자 발생 시 접촉 직원인 경우

① 해당부서는 감염관리실에 연락하고 접촉자를 분류하여 추가적인 검사를 실시한다.

② 접촉자는 밀폐된 실내공간에서 환자와 접촉한 적이 있는 직원을 의미하며, 밀접접촉자와 일상접촉자로 분류한다.

■ 밀접접촉자: 환자와 같은 밀폐된 실내 공간에서 개인보호구를 착용하지 않은 상태로 하루에 연속적으로(또는 매일) 8시간 이상 접촉하거나 누적기준으로 40시간 이상 접촉한 자

■ 일상접촉자: 접촉자 중 밀접접촉자가 아닌 자

※ 단, 현장 조사 등의 결과에 따라 기준시간 이하로 접촉한 일상 접촉자로 밀접접촉자에 포함 할 수 있음

(나) 폐결핵이 확인된 직원인 경우

① 활동성 폐결핵 진단을 받은 직원은 적절한 치료를 받은 후 호흡기 증상이 호전되고 객담 AFB 검사상 3회 연속 음성 통보를 받을 때까지 근무를 제한한다.

② 완치 전 임의로 투약을 중단한 직원의 경우 치료를 다시 시작할 때까지, 치료에 대한 적절한 반응이 확인될 때까지, 객담 AFP가 음성으로 나올 때까지 근무를 제한한다.

(2) 홍역, 수두 등 공기매개 감염질환 노출 시 감염관리학회 권고사항에 따른다.

(가) 홍역

① 접촉자 중 홍역에 대한 면역력의 증거가 없는 사람(MMR 백신 2회 접종력이 없는 경우, 홍역 항체 음성자 등)은 노출 후 72시간 내에 홍역백신을 접종한다.

② 감수성이 있는 접촉 직원 중 합병증 발생위험이 높은 임신부와 면역저하자의 경우 노출 후 6일 이내에 면역글로불린을 0.25ML/10kg을 근육주사 한다.

③ 홍역에 걸린 직원은 발진 발현 후 7일까지 혹은 급성감염 기간 동안 근무를 제한한다.

(나) 수두

① 노출 즉시 항체검사를 시행한다.

② 노출자 중 수두 접종력이 없고, 과거에 수두를 앓은 적이 없는 경우 노출 후 3~5일 이내 수두 백신을 접종하며(한달 간격 2회), 첫 노출 후 10일째부터 마지막 노출 21일까지 근무를 제한한다.

③ 감수성이 있는 접촉 직원 중 합병증 발생위험이 높은 임신부와 면역저하자의 경우 노출 후 10일 이내에 VZIG 면역글로불린을 투여하고, 첫 노출 후 10일째부터 마지막 노출 28일까지 근무를 제한한다.

④ 수두백신을 접종받은 직원이 노출된 경우 노출 후 가능한 빨리 항체 검사를 실시하고 항체가 양성이면 환자 접촉 가능함. 항체가 음성인 경우 5~6일 후 재검사하여 양

성으로 확인 되면 면역성 있다고 간주하여 항체가 계속 음성이면 첫 노출 후 10일째부터 마지막 노출 후 21일까지 환자 접촉을 제한하거나 근무를 제한한다.

⑤ 노출 후 수두병변이 있는 경우에는 모든 병소가 딱지가 될 때까지 환자와 접촉을 금지한다.

다) 비말감염 질환 노출 시

(1) 유행성 이하선염

(가) 접촉 후 예방접종 및 면역글로불린은 필요하지 않다.

(나) 노출된 직원 중 감수성이 있는 자는 첫 노출 후 12일 째부터 마지막 노출 후 26일 째까지 혹은 증상이 발생했다면 이하선염 시작 후 9일까지 근무를 제한한다.

(2) 백일해

(가) 적절한 보호조치 없이 백일해 환자와 접촉(호흡기 분비물과 직접 접촉)한 직원이 의심 증상이 있는 백일해의 경우, 예방적 항균제를 투여하고 5일간 근무제한을 고려한다.

(나) Erythromycin을 500mg을 하루 4회 또는 trimethoprim sulfamethoxazole 1T를 하루 2회 노출 후 14일간 복용한다.

(3) 인플루엔자

(가) 증세가 시작되기 24시간 전부터 바이러스를 배출하여 약 10일간 계속되며 소아의 경우 이 기간이 연장될 수 있다. 한 명의 환자가 여러 사람에게 감염을 전파하므로 원내에서 집단적으로 감염이 발생할 위험이 높고 특히 직원의 감염은 많은 환자에게 전파시킬 위험성이 크다.

(나) 유행 시기에는 필수적으로 호흡기 증상이 있을 경우 마스크를 착용하고 기침 에티켓을 준수한다.

(다) 환자와 직접 접촉을 하는 직원은 매년 가을 예방접종을 실시한다.

(라) 감염이 되었거나 의심되는 직원은 급성기에는 환자 접촉을 가급적 피하고 전파기간 동안 마스크를 착용하고 기침 에티켓을 준수한다.

라) 접촉주의 관련 질환 노출 시 조치사항

(1) 설사

(가) 심한 설사: 발열이나 복통, 혈변을 동반하는 설사가 24시간 이상 지속되는 경우는 검사 결과가 확인될 때까지 환자와의 접촉을 제한하고 진료를 받는다.

(나) 장내세균으로 인한 설사로 확인되면 즉시 치료를 시작한다.

(다) 장티프스로 인한 설사는 항생제 투약이 끝난 후 3일 연속으로 실시한 대변배양검사에서 균이 자라지 않을 때까지 근무를 제한한다.

(2) A형 간염

(가) A형 간염은 분변-구강 경로로 감염되며, 주로 신생아나 다른 이유로 입원한 소아에게서 불현성 감염이나 잠복기 상태로 감염되어 있는 경우가 많다.

(나) A형 간염이 유행할 때에는 잠복기를 포함한 A형 간염 환자의 배설물과 대변에 구강 노출된 직원에게 면역글로불린(0.02mg/kg 1회 근육주사) 투여를 고려할 수 있다.

(다) 이 경우 환자의 혈청 검사에서 A형 간염이 있음을 반드시 확인하여야 하며 그 외

접촉자는 예방조치가 필요하지 않다.

(라) 노출 후 2주 이내에 에방접종 및 면역 글로불린을 투여하면 85%에서 감염이 예방되거나 증세를 약화시키는 효과가 있다.

(마) 감염된 직원은 황달이나 다른 증세가 시작된 후 7일간 근무를 제한한다.

(바) 감염 전파차단을 위한 주의사항은 다음과 같다.

① 손위생을 철저히 한다.

② 환자가 있는 장소에서 음식을 먹거나 마시지 않는다.

③ 일반적인 위생관념에 유의한다.

(3) 단순포진 감염증

(가) 직원의 손이나 다른 국소 감염은 고위험군의 환자에게 감염을 전파시켜 심각한 결과를 초래할 수 있다.

(나) 바이러스가 분리되는 사람의 체액이나 상처와 직접 접촉하였을 경우 전파가 가능하므로 감염된 직원은 다음과 같은 주의가 필요하다.

① 일차 혹은 재발성 구강-안면 단순포진이 생긴 의료진의 병변이 없어질 때까지 고위험 환자(면역기전저하 환자, 신생아, 화상환자) 와 접촉을 제한한다.

② 손에 단순포진이 생긴 의료인은 병변이 치유될 때까지 가능한 환자와 접촉하지 않는다.

③ 감염 병변이 있는 부위를 노출시키거나 손대지 않도록 주의하고 손위생 등의 표준주의를 철저히 준수한다.

(4) 유행성 각결막염(conjunctivitis)

(가) 전염성이 높은 유행성 각결막염을 주로 일으키는 것은 아데노바이러스이다.

(나) 유행성 각결막염은 병원 내에서 유행적으로 발생하기 쉬우며, 특히 외래에서 근무하는 직원의 경우 감염되기 쉽다.

(다) 유행성 각결막염에 감염된 직원은 질병기간 동안 근무를 제한하며, 손위생을 철저히 한다.

(5) Grop A Streptococcus 감염증

(가) 전파경로는 분비물과의 직접 접촉에 의해 주로 전파되며 감염자의 인두, 피부, 직장, 질에 집락을 형성한다. 드물게 공기를 통하여 전파되는 경우도 있다.

(나) 유행적 발생과 관련이 있다면 상기도에 균이 분리된 직원은 보균상태가 해결될 때까지 근무를 제한한다.

(다) 삼출성 피부병변에서 분리되는 직원은 적절한 치료를 받고 24시간이 지날 때 까지 환자 접촉이나 음식을 다루는 일에서 제외한다.

(6) 옴(Scabies)

(가) 옴에 감염된 환자의 피부에 지속적으로 밀접하게 접촉한 경우 전파될 수 있으므로 감염환자 발생 시 신속히 노출자 관리를 시행한다.

(나) 노출자의 범위는 개인보호구 착용이나 손위생 없이 옴 환자 또는 노출자중 증상이 있는 사람과 밀접하게 피부접촉을 한 경우이다.(예를 들어 껴안거나, 깍지를 끼거나, 5~10분 이상 접촉한 경우)

(다) 손위생이나 샤워 등 개인위생을 잘 수행한 경우 노출 시 감염 위험성이 낮으므로

예방적 약물 도포 여부 결정 시 증상발생 유무와 노출정도(기간 및 접촉 등)를 함께 고려한다.

(라) 옴 환자와 직접 접촉이 없는 경우 예방적 치료가 필요하지 않으나, 노출된 직원은 예방적 치료를 실시한다.

(마) 예방적 치료는 10% crotamion 연고 혹은 5% permethrin 연고 등의 사용을 고려할 수 있으며, 1회 도포 후 다음날부터 근무가 가능하다.

(바) 밀접 접촉했던 모든 사람은 증상 유무에 관계없이 동시에 치료를 실시한다.

(사) 옴 진단을 받은 직원은 완치 될 때 까지 근무를 제한한다.

(7) 이(Pediculosis)

(가) 환자와 접촉한 직원은 모든 피부에 문제가 있는지 관찰한다.

(나) 감염된 직원은 다른 환자나 직원에게 전파되지 않도록 효과적인 국소치료제를 이용하여 신속히 치료한다.

(다) 증상이 있는 직원의 경우 적절한 치료제를 도포한 후 24시간 까지 근무를 제한한다.

마) 신종감염 질환 노출 시

(1) 개인보호구를 착용하지 않고 신종감염병 확진자에게 노출되었을 경우 즉시 능동 감시를 시행한다.

(가) 노출 후 유사 증상 시 보호구 착용 등 감염예방 조치를 준수하고 해당 진료를 받도록 한다.

(나) 노출 후 의심환자로 진단 된 경우 관할 보건소에 신고하고 국가지정 입원치료병상으로 이송하여 검체 채취 후 치료를 받도록 한다.

(다) 노출 후 무증상 시 잠복기간 동안 해당 보호구를 착용하고 격리한다.

(라) 확진환자의 무증상 밀접 접촉자는 일정기간 경과 후 신종감염병 진단검사를 실시하고 결과가 음성일 때 격리를 해제한다.

(마) 노출 후 잠복기 동안 이동을 제한하고 자가 격리 또는 병원격리를 시행한다.

(2) 의심환자와 밀접 접촉한 경우 수동감시를 시행한다.

(가) 노출 후 감시기간 중 유사증상이 나타날 경우 즉시 보건소에 신고한다.

(나) 노출 후 의심환자로 분류될 경우 국가지정 입원치료 병상으로 이송 조치한다.

(다) 전파경로별 신종감염병 질환의 감염관리 방법에 따라 추적검사 및 추후관리를 시행한다.

(라) 해당 신종감염병에 따라 직원의 근무를 제한한다.

바) 감염원에 따른 근무제한 조치 절차

감염성질환을 앓고 있는 직원이 다른 직원이나 환자에게 옮기지 못하도록 감염의 전파경로나 질병의 특성에 따라 근무제한 조치를 할 수 있다.

다. 직원 감염 노출 외 안전사고 보고체계

1) 직무 중 상해 및 부상 발생 시 보고체계

가) 직무중 상해 및 부상이 발생한 경우 응급조치 및 긴급 사고처리를 진행한다.

나) 상해를 입은 직원은 안전사고 발생에 대한 사항을 부서장에게 구두 보고한다.

다) 평일 주간은 본원 외래, 야간에는 타병원 응급실 진료를 받는다.

라) 안전사고 발생부서의 부서장은 직원 안전사고 보고서 또는 별도의 유해화학물질 노출 사고보고서를 작성 후 72시간 이내에 원무과장에게 제출한다.

마) 공상 행정처리 필요 시 원무과장은는 안전사고 발생부서로부터 통보 받은내용을 토대로 병원장에게 보고 후 진료비 공상처리를 진행한다.

2) 감염노출을 포함한 직원 안전사고 발생 보고체계는 원내 게시판 게시를 통해 전 직원과 공유한다.

3) 직원 감염 노출 외 안전사고 치료 및 관리절차

가) 사고 유형에 따른 조치사항

(1) 감염노출 외 안전사고 발생 시

(가) 감염노출 외 안전사고 발생 시 적절한 응급조치를 시행한다.

(나) 응급조치 후 부서장에게 보고하고 주간에는 외래 진료, 야간 및 공휴일에는 필요 시 타병원 응급실에서 진료를 받는다.

(다) 직원안전사고 보고서를 작성 후 보건관리자에게 제출하고 추후 관리를 받는다.

(2) 유해물질 노출 시

(가) 눈에 들어갔을 때 : 눈 접촉 시 흐르는 물 또는 Eye wash station을 사용하여 눈 안쪽에서 바깥쪽으로 15분 이상 세척한다.

(나) 피부에 접촉했을 때 : 즉시 많은 양의 물과 비누로 씻어 화학물질을 제거하고 피부 질환 발생 시 의사의 진찰을 받는다.

(다) 흡입했을 때 : 유해화학물질을 흡입한 경우 신선한 공기로 이동하고 이상이 발생했을 시 즉시 의사의 진찰과 치료를 받는다.

(라) 먹었을 때 : 구토를 유도하지 말고 물로 입안을 헹군다.

(마) 직원이 유해화학물질에 노출되었을 경우 응급처치를 실시한 후 필요시 타병원 응급실로 이송하고, 절차에 따라 보건관리자에게 보고한다. 보고 받은 보건관리자는 필요한 조치를 실시한다.

(바) 유해화학물질이 누출되었을 경우 Spill kit를 사용하여 처리한다.

나) 발생 시 조치사항

(1) 사고발생 즉시 응급처치 시행 후 직원안전사고 발생 보고체계에 따라 보고한다.

(2) 직원의 안전사고 발생 시 「산업안전보건법」 제57조에 따라 사망 또는 3일 이상 휴업이 필요한 경우 관할 노동관서에 산업재해 발생을 보고한다.

(3) 안전사고 발생 부서에서는 재발 방지를 위한 안전교육을 실시하고, 안전사고 발생분석과 개선활동을 수행한다.

10. 직원 안전사고 처리 결과 경영진 보고

가. 감염노출 포함한 안전사고 피해 직원은 원무과에 비치된 공상승인 신청서를 작성하여 부서장의 동의를 득한 후 진단서, 입퇴원확인서, 진료비 영수증 등의 근거자료와 함께 원무과에 제출한다.

나. 보고받은 원무과장 및 감염관리전담자는 직원 안전사고 처리 결과에 대해 직원안전사고 원인분석 재발방지 대책 보고서를 작성하여 병원장에게 보고한다.

▣ 부록 (Appendix)

1. 직원 안전사고보고/유해인자 노출사고 발생 시 처리절차 흐름도
2. 직원 감염사고 발생 시 처리절차 흐름도
3. 직원 감염성질환 노출 보고서
4. 직원 안전사고 보고서
5. 직원 유해인자 노출 보고서
6. 공상 승인 신청서
7. 직원건강 및 안전관리를 위한 연간활동 계획
8. 직원 안전사고 원인분석 재발방지 대책 보고서
9. 건강검진 미수검자 관리 대장
10. 보건 상담일지

▣ 규정 개정일 [누적]

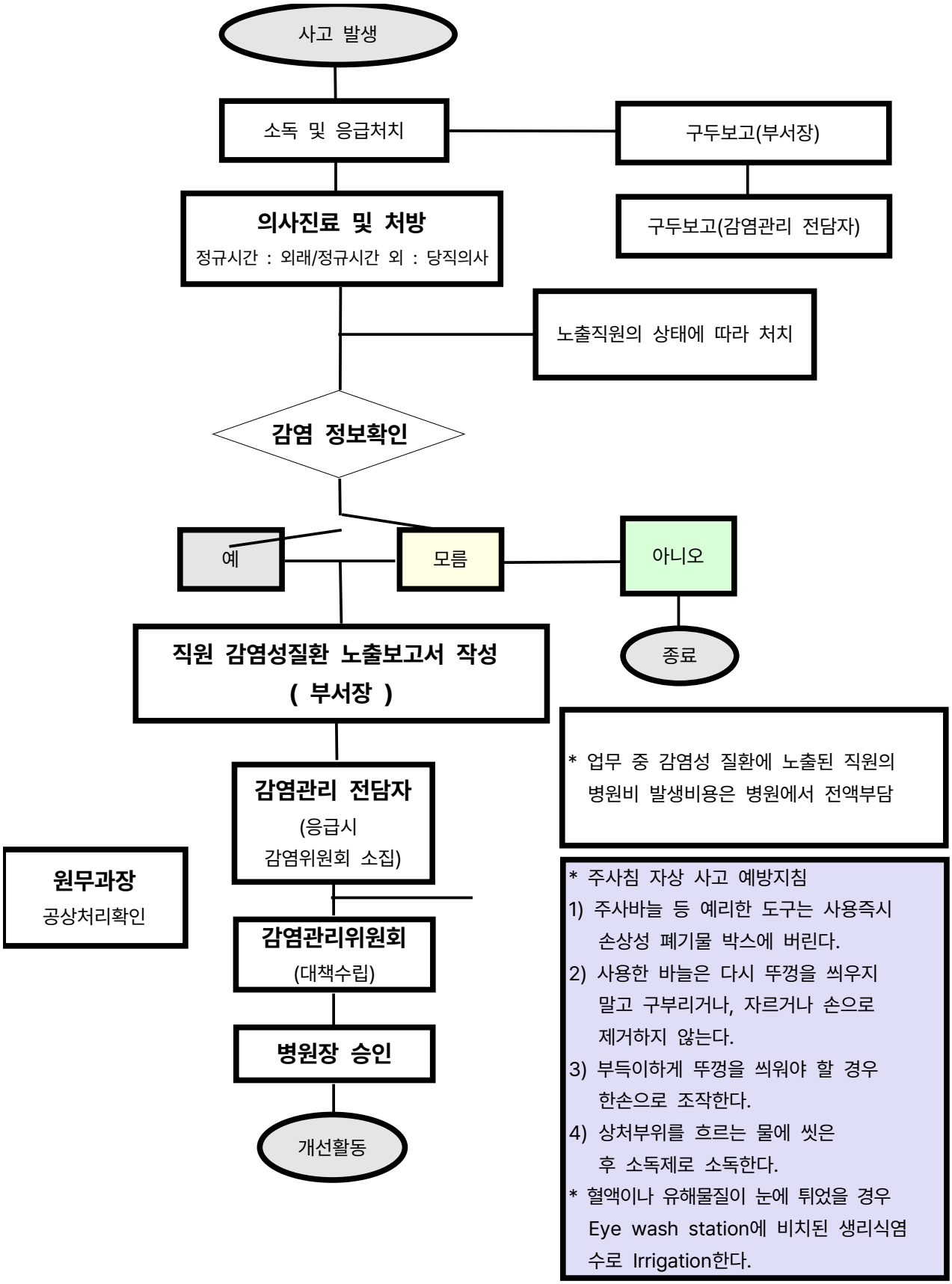
2025년 10월 15일 개정하고 2025년 11월 1일 시행한다.

승 인 책 임 자	병원장	이름		서명	
승 인 일	. . .				

직원 안전사고/유해인자 노출사고 발생 시 처리절차

부록2. 직원감염사고 발생 시 처리절차 흐름도

직원 감염사고 발생 시 처리절차


사고 발생
소독 및 응급처치
구두보고(부서장)
의사진료 및 처방
정규시간 : 외래/정규시간 외 : 당직의사
구두보고(감염관리 전담자)
노출직원의 상태에 따라 처치
감염 정보확인
예
모름
아니오
종료
직원 감염성질환 노출보고서 작성
(부서장)
감염관리 전담자
(응급시
감염위원회 소집)
원무과장
공상처리확인
감염관리위원회
(대책수립)
병원장 승인
개선활동
* 업무 중 감염성 질환에 노출된 직원의 병원비 발생비용은 병원에서 전액부담
* 주사침 자상 사고 예방지침
1) 주사바늘 등 예리한 도구는 사용즉시 손상성 폐기물 박스에 버린다.
2) 사용한 바늘은 다시 뚜껑을 씌우지 말고 구부리거나, 자르거나 손으로 제거하지 않는다.
3) 부득이하게 뚜껑을 씌워야 할 경우 한손으로 조작한다.
4) 상처부위를 흐르는 물에 씻은 후 소독제로 소독한다.
* 혈액이나 유해물질이 눈에 튀었을 경우 Eye wash station에 비치된 생리식염수로 Irrigation한다.

부록3. 직원 감염성질환 노출 보고서

직원 감염 노출 사고 보고서

부서장	감염관리 전담자	병원장

본인에 대한 정보 (연락처 H.P :)

직원명 : _____ 사번 : _____ 성별/나이 : ____/____

부서/직위 : _____ 생년월일 : _____ 경력 : ____년____개월

B형 간염 접종 : 유 ☐ 무 ☐ 모름 ☐ B형 간염 항체 : 유 ☐ 무 ☐ 모름 ☐ 임신여부 : 유 ☐ 무 ☐

환자에 대한 정보 ☐ 환자를 알 수 없음 ☐ 검사일자 : ____년____월____일

성명 : _____ 성별/나이 : ____/____ Hosp.No. : _____ 병실 : _____ 진단명 : _____

위험원인체 : ☐ Hbs Ag ☐ Hbc Ag ☐ Hbe Ag ☐ Anti-HCV ☐ HIV

☐ VDRL ☐ 기타 _____ ☐ 검사결과 없음

사고 발생 유형 및 경위

노출일시 : ____년____월____일 노출장소 : _____ 발생부위 : _____

노출대상 : ☐ 환자 ☐ 주사침 ☐ 혈액 ☐ 물품 _____

노출경로 : ☐ 수술 및 시술 중 ☐ 주사처치 중 ☐ 정맥혈채취 중

☐ 동맥혈채취 중 ☐ Recapping ☐ 분기수거 중

☐ 기타(구체적으로 기술 바람) _____

사고발생경위(육하원칙에 준하여 자세히 기록) :

위와 같이 감염노출사고 보고와 업무상 공상처리를 요청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

년 월

_____(서명)

조치사항 ☐ 노출원(환자)에 대한 검사 필요함 (처방내용기재)

① 소견

② 검사

③ 처방

④ 추후관리 진료의 _____(서명)

추후관리

승인을 요하는 사항 진료비 감면 : 현재까지의 진료비 _____원

부록4. 직원안전사고 보고서

직원안전사고 보고서

결재	담당자	부서장	병원장

발생일시 : 년 월 일			발생장소 :	
보 고 일 : 년 월 일				
인적사항	성 명		소속 및 직위	
사고 개요	1. 발생원인 누가 : 언제 : 어디서 : 무엇을 : 어떻게 : 왜 : 2. 결과			

위와 같이 직원안전사고를 보고합니다.

년 월 일

보고자 (서명)

부록5. 직원 유해인자 노출 보고서

유해인자 노출사고 발생 보고서

결재	담당자	부서장	병원장

인적사항	소속		직위		입사일	20 년 월 일
	성명		성별	▢남 / ▢여	나이	
유해인자 (MSDS 참조)						
노출일시	20 년 월 일 시 분					
노출경위						
노출구분	▢ 눈	▢ 피부	▢ 흡입	▢ 섭취		

위와 같이 보고합니다.

20 년 월 일

보고자 (서명)

부서장 (서명)

부록6. 공상 승인 신청서

공상 승인 신청서

결재	담당자	부서장	병원장

1. 공상처리대상자

부 서 : 직 위 : 성명 :

근무부서 : 임용일 :

2. 공상내용(육하원칙에 의거 기술) :

3. 승인을 요하는 사항

가. 진료비 감면 : 현재까지의 진료비 : 원

추후 예상 진료비 : 원

나. 요양 기간 중 공가처리 : 년 월 일부터

년 월 일까지 (일간)

상기와 같이 공상처리를 요청하오니 승인하여 주시기 바랍니다.

년 월 일

신청자 : (서명)

부서장 : (서명)

부록7. 직원건강 및 안전관리를 위한 연간 활동 계획

직원건강 및 안전관리를 위한 연간 활동계획

결재	담당자	부서장	병원장

구분	항목	담당자	일정 (월)												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	예산
인플루엔자 예방접종	대상자 선정														
	접종 실시														
B형간염 예방접종	대상자 선정														
	접종 실시														
정기 건강검진	확정자명단 작성														
	일반검진실시														
	결핵검진														
	잠복결핵검사														
	2차검진실시 (미검진자포함)														
	특수건강검진실시														
	유소견자관리														
	건강검진결과 보고														
채용 시 건강검진	검진실시														
	B형간염검사														
유해물질관리	MSDS자료배포														
	신규, 변경현황조사														
교육훈련계획	산업안전보건교육														
	성희롱예방교육														
업무상재해	폭언 및 폭행예방교육														
	유해인자물질 교육														
업무환경 관리	시설안전교육														
	작업환경측정														
														합 계	

부록8. 직원안전사고 원인분석 재발방지 대책 보고서

직원 안전사고 원인분석 및 재발방지 대책 보고서	결재	담당자	부서장	병원장

재해일자	20 년 월 일 시 분 요일			
부 서 명		주민등록번호		
재해자 인적사항	성 명		전화번호	
	임용일		직 종	
재해발생경위 (육하원칙에 의거 상세히 기록)	언제 : 어디서 : 누가: 무엇을 : 어떻게 : 왜 :			

※ 원인 분석 및 재발방지 대책

재해유형	상해부위		상해종류		발생형태		기인물	
재해원인 및 분석	원인 : 분석 :							
재발방지 대 책								

제출일: 20 년 월 일

작성자: (인)

부록9. 건강검진 미수검자 관리대장

건강검진 미 수검자 관리 대장

20 년

번호	부서	성명	입사일	검진일	비고 (검진확인)

부록10. 보건 상담일지

보건관리자 상담일지

직원명		성별/나이		부서
상담사유		상담일자		

내용	1.상담내용 ▢ 직원안전사고 ▢ 잠복결핵 ▢ B형 간염 ▢ 성인병 질환 ▢ 기타( )
	2.건강위험요인
진행사항	
결과	
상담내용	